



جوستاف روسي انترناشيونال - مصر (EPE) * طلب علاج أول مرة / متكرر

إسم المريض ربيعاً : رشا جمال محمد ابراهيم

المحافظة : القاهرة الحي / المدينة : عين شمس العنوان : -

رقم البطاقة : 28612100101743 رقم التليفون : 01062076366 تاريخ تسجيل الإستمارة : 19-09-2026

العمر (تاريخ الميلاد) : 10-12-1986 المهنة : ربه منزل

الإقرار

أقر أنا الموقع أدناه أنني لا اتمتع بأي نظام علاج مثل:- التأمين الصحي-القوات المسلحة-الشرطة-الهيئات-المؤسسات أو أي نظام يتعارض مع نظام العلاج علي نفقة الدولة- وسوف اتحمل كافة نفقات العلاج في حالة ثبوت غير ذلك

الإحصائي الاجتماعي (.....) التوقيع: (.....)

المقرر بما فيه (.....) التوقيع: (.....)

التشخيص الإكلينيكي : سرطان بالثدي (مبادرة)

نتائج الأبحاث : (مرفق)

التشخيص النهائي : سرطان بالثدي (مبادرة)

خطة العلاج : أبحاث أورام ماموجرام وسونار علي الثديين [10888] قسم العلاج : الاورام

التعليق على التشخيص :

تقرير اللجنة الثلاثية المتخصصة

الاسم : د/محمد كيلاني الوظيفة : التوقيع :
الاسم : د/ندى حسن الوظيفة : التوقيع :
الاسم : د/نرمين رمضان الوظيفة : التوقيع :
أطلعت اللجنة علي لائحة العلاج الخاصة بالمجالس وتلتزم جهة العلاج بلائحة المجالس الطبية. كما تقرر اللجنة بأن البيانات المدونة في هذا النموذج صحيحة.

تعهد المستشفى أن لا يتم تنفيذ القرار إلا بعد مراجعة الملف الطبي للمريض وإعادة مناظرة المريض بالمستشفى قبل الصرف.

أعضاء اللجنة

..... د/..... د/..... د/..... د/.....

قرار اللجنة

التشخيص النهائي :
خطة العلاج :
المستشفى : قسم :
جهة العلاج : نفقات :
ملاحظات :

ختم
شعار الجمهورية

مدير عام
مديرية الشؤون الصحية

رئيس
المجلس الطبي المتخصص

--

Name: رشا جمال محمد ابراهيم National ID: 28612100101743	
--	---

تقرير طبي

السيد
تحية طبية وبعد,,

إيماء للطلب المقدم من	بشأن تقرير طبي للمريض
بقسم:	رقم طبي:

نتشرف بان نوضح فيما يلي تقريرنا عن حالته
--

تاريخ وساعة الدخول : -- --:-- yyyy-mm-dd	تاريخ وساعة الخروج : PM 01:17 05-07-2026
---	---

وبعد الكشف والفحوصات والمتابعة وجد انه
--

المریضة تعاني من ورم غير حميد بالثدي و تحتاج الي Bilateral mammogram and breast ultrasound
--

التاريخ : 05-07-2026	الوقت : -- --:--
	الطبيب المعالج : د/شيماء لاشين

٢٠٢٤/٠٨ ٢٨١٢٣٠٠١٠١٧٤٣
 ربة منزل
 إثنى عشرية
 صديق عبدالقادر خضر علي
 البطاقة سارية حتى ٢٠٣٧/٠٨/١١




جمهورية دولة فلسطين
 وزارة الداخلية
 رانيا
 جمال محمد البراهيم
 ١ شربع الآخر
 بولاق - القاهرة




٢٨١٢٣٠٠١٠١٧٤٣

KR7413824

١٥٨٨٥

أومينا

Name : Rasha Gamal Mohamed Ibrahim

Date : 16-12-2025 09:58

Branch : Portable

Medical No. : GRI-79114

Ref.Physician Prof :

Ins.Company :

**POST-CONTRAST MULTI-SLICE CT SCAN OF THE CHEST, ABDOMEN,
AND PELVIS: -**

Findings:

Compared to the previous study dated 16/9/2024, the current study showed:

I Chest:-

- Newly developed right breast edema and skin thickening.
- Newly developed right upper and middle lung lobes reticulations and ground glass density likely post radiation sequelae.
- No appreciable time interval changes regarding the previously seen two small righty upper lobe pulmonary lung nodules.
- Few left lower lung lobes fibroatelectatic bands seen.
- No sizable pulmonary masses, areas of consolidation or cavitary lesions.
- No hilar or mediastinal lymph nodes.
- No evidence of pleural effusion, pleural thickening or masses seen.
- Normal cardiac size and shape with no gross abnormality of the cardiac chambers. No pericardial effusion detected.
- Normal CT appearance of the thoracic aorta and the great vessels.

II Abdomen & pelvis:

- Post operative status showing anterior abdominal wall incisional hernia at the right lumbar region containing bowel loops.
- The previously seen right adrenal soft tissue mass lesions are no longer seen in today's study.
- The liver is of average size with homogenous CT texture. No definite focal lesions or contour irregularities.
- No intra-hepatic or extra-hepatic biliary radicles dilatation.
- Normal size & parenchymal texture of the spleen with no focal lesions seen.

Name : Rasha Gamal Mohamed Ibrahim

Date : 16-12-2025 09:58

Branch : Portable

Medical No. : GRI-79114

Ref.Physician Prof :

Ins.Company :

- Normal size, parenchymal thickness & density of both kidneys with no stones or back-pressure changes.
- Normal appearance of the pancreas, aorta, I.V.C and left suprarenal.
- Smooth filling of the urinary bladder with no filling defects or diverticular outpouching.
- Regressive course mounting to complete resolution regarding the previously seen right adenexal cystic lesion.
- Stationary course regarding the size of the previously seen small left adenexal cyst.
- No abdominal or pelvic masses or collections.

III Scanned skeleton:

- Early lumbar spodylodegenerative changes.
- L4 limbus vertebra.
- No definite worrisome lytic or sclerotic focal lesions.

Opinion:

- Newly developed right breast edema and skin thickening for sono-mammography.
- Post operative status showing clear operative bed with no residual abdominal lesions.
- Newly developed anterior abdominal wall incisional hernia.
- Regressive course mounting to complete resolution regarding the right adenexal cystic lesion.
- Stationary course regarding the rest of the study.

Dr. Mohamed Mohsen, M.D.